

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Όνομα Nikolaos Papadopoulos
Ηλικία 64
Φύλο male

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

- Πενικιλίνη - διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα (καταγεγραμμένο 2018)

ΚΛΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Γνωστή υπέρταση από 5ετίας υπό μονοθεραπεία. υποβέλτιστος έλεγχος αρτηριακής πίεσης τους τελευταίους 12 μήνες.
- Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 διαγνωσμένος προ 8 ετών. υπό μετφορμίνη 1000 mg δύο φορές ημερησίως.
- Ενεργός καπνιστής (~30 pack-years). είχε αρνηθεί στο παρελθόν τη διακοπή.
- Χωρίς προηγούμενο έμφραγμα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή χρόνια νεφρική νόσο.
- Ο πατέρας απεβίωσε από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε ηλικία 60 ετών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ

- Troponin I.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma: 14200 ng/L (< 14)
- Cholesterol [Mass/volume] in Serum or Plasma: 245 mg/dL (< 200)
- Cholesterol in LDL [Mass/volume] in Serum or Plasma: 160 mg/dL (< 100)
- Cholesterol in HDL [Mass/volume] in Serum or Plasma: 32 mg/dL (> 40)
- Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood: 7.8 % (< 6,5)
- Creatinine [Mass/volume] in Serum or Plasma: 1.1 mg/dL (0,6-1,2)
- Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted: 68 mL/min/1,73m² (> 60)
- Left ventricular Ejection fraction: 45 % (> 55)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οξύ διατοχωματικό πρόσθιο έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI)

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ

- Ιδιοπαθής αρτηριακή υπέρταση
- Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 χωρίς επιπλοκές
- Μικτή υπερλιπιδαιμία
- Διαταραχή χρήσης καπνού (ενεργός καπνιστής, ~30 pack-years)
- Οικογενειακό ιστορικό πρόωρης στεφανιαίας νόσου

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

- Πρωτογενής διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) μέσω δεξιάς κερκιδικής προσπέλασης
- Εμφύτευση φαρμακοεκλυόμενου stent (DES) στον εγγύς αριστερό πρόσθιο κατιόντα κλάδο (LAD)
- Αποκατάσταση ροής TIMI 3 μετά την PCI
- Έναρξη διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (DAPT: ασπιρίνη + τικαγρελόρη)
- Έναρξη Καρδιακής Αποκατάστασης Φάσης I πριν από το εξιτήριο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άνδρας 64 ετών, καπνιστής, με υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με έντονο οπισθοστερνικό θωρακικό άλγος διάρκειας 90 λεπτών, με αντανάκλαση στο αριστερό άνω άκρο, εφίδρωση και προοδευτική δύσπνοια σε ελάχιστη προσπάθεια. Το ΗΚΓ ανέδειξε ανάσπαση του διαστήματος ST ≥ 2 mm στις απαγωγές V1-V4, συμβατή με οξύ πρόσθιο έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση ST (STEMI). Ο ασθενής μεταφέρθηκε επειγόντως στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Η στεφανιογραφία ανέδειξε θρομβωτική απόφραξη 95% του εγγύς τμήματος του αριστερού προσθίου κατιόντος κλάδου (LAD). Τοποθετήθηκε επιτυχώς φαρμακοεκλυόμενο stent, αποκαθιστώντας ροή TIMI 3. Η μέγιστη τιμή της υψηλής ευαισθησίας τροπονίνης I έφθασε τα 14.200 ng/L. Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα μετά την επέμβαση ανέδειξε ελαφρώς μειωμένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (45%) με υποκινησία του προσθίου τοιχώματος και του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή συνεχίστηκε. Ο ασθενής παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερός, χωρίς υποτροπή θωρακικού άλγους ή αρρυθμιών, και κρίθηκε κατάλληλος για εξιτήριο με δομημένη καρδιολογική παρακολούθηση και ένταξη στο πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ

Φάρμακο	Δόση	Σκοπός	Πρόγραμμα
Acetylsalicylic acid	100 mg ημερησίως	Αντιαιμοπεταλιακό - προλαμβάνει θρόμβους	Πρωί
Ticagrelor	90 mg δύο φορές ημερησίως	Αντιαιμοπεταλιακό - προστατεύει το νέο stent	Πρωί και βράδυ
Atorvastatin	80 mg ημερησίως	Μειώνει τη χοληστερόλη και σταθεροποιεί τις αρτηρίες	Βράδυ
Ramipril	2,5 mg ημερησίως	Προστατεύει την καρδιά και μειώνει την πίεση	Πρωί
Metoprolol	25 mg ημερησίως	Επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό και προστατεύει την καρδιά	Πρωί
Metformin	1000 mg δύο φορές ημερησίως	Για έλεγχο της αντιδιαβητικής αγωγής	Πρωί και βράδυ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Καρδιολογικό εξωτερικό ιατρείο σε 14 ημέρες. Ημερήσιο ημερολόγιο αρτηριακής πίεσης στο σπίτι. Ραντεβού για συμβουλευτική διακοπής καπνίσματος εντός 7 ημερών. Καρδιακή αποκατάσταση Φάσης II σε 3 εβδομάδες. Επανάληψη λιπιδαιμικού προφίλ, HbA1c και νεφρικής λειτουργίας σε 3 μήνες.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ — ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 112 ΕΑΝ:

- ! Υποτροπιάζων θωρακικός πόνος ή πίεση διάρκειας άνω των 5 λεπτών
- ! Δύσπνοια σε ηρεμία ή νυχτερινή επιδείνωση
- ! Αιφνίδια ζάλη, λιποθυμία ή σχεδόν λιποθυμία
- ! Αιφνίδιο οίδημα αστραγάλων ή ποδιών
- ! Αιμορραγία που δεν σταματά εντός 10 λεπτών (υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή)
- ! Οποιοδήποτε νέο νευρολογικό σύμπτωμα (αδυναμία, μπερδεμένη ομιλία, απώλεια όρασης)

ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνθετικό και ανωνυμοποιημένο έγγραφο για επίδειξη του HealthClarify. Δεν αποτελεί πραγματικό ιατρικό αρχείο.